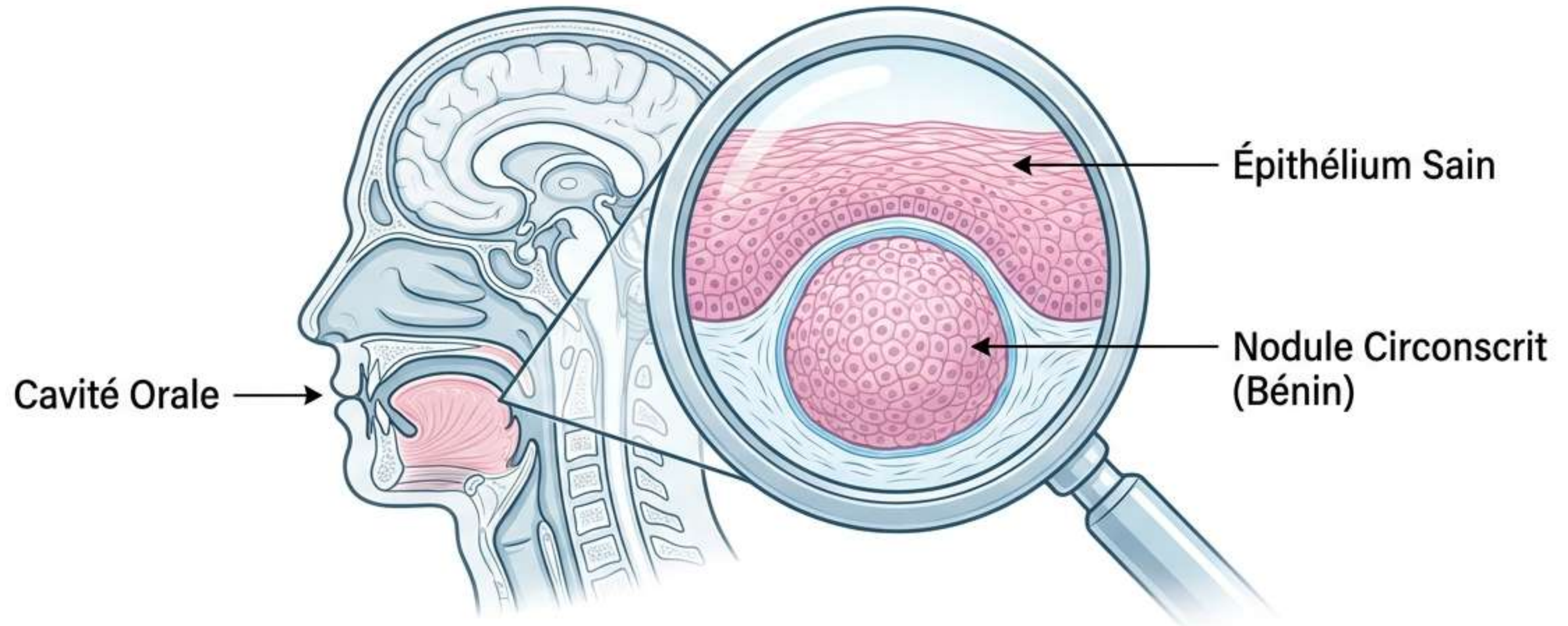


TUMEURS BÉNIGNES DE LA MUQUEUSE BUCCALE

Atlas Clinique, Histologique et Stratégies d'Examen

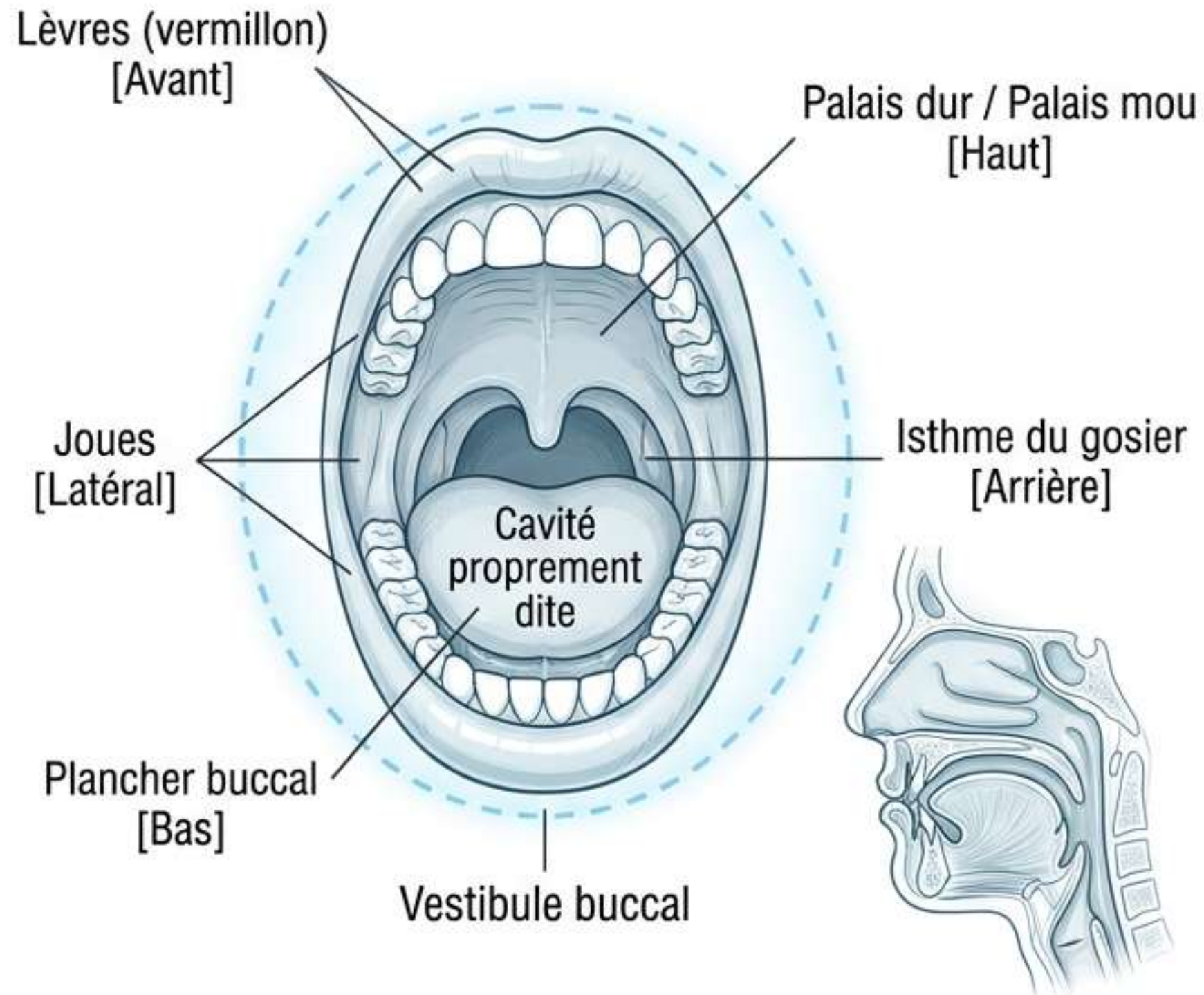


Synthèse intégrale des fondations anatomopathologiques, incluant l'analyse des annales et les prédictions d'examen.

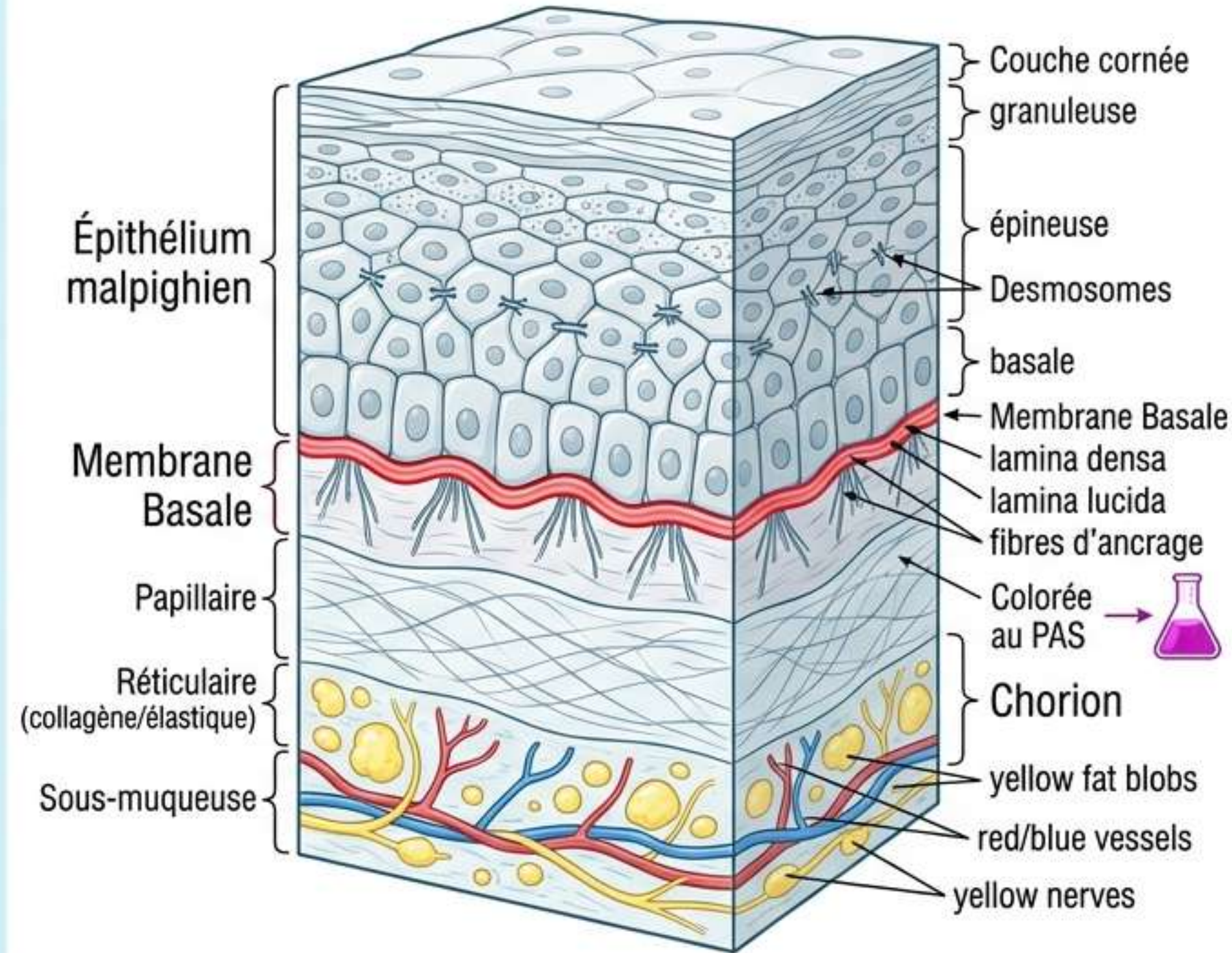
QUESTION D'ANNALE TYPE : Décrire l'aspect macroscopique et microscopique d'un nodule bénin de la muqueuse buccale. Citez les deux diagnostics différentiels principaux.

PRÉDICTION EXAMEN : Grande probabilité de cas clinique sur le diagnostic différentiel entre un nodule bénin et une lésion précancéreuse, en se basant sur l'histopathologie et la présentation clinique. Focus sur la dysplasie

Architecture Saine : Le Premier Segment du Tube Digestif

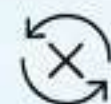
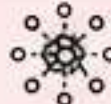


Kératinisation : Muqueuses masticatrices (gencive, palais dur) + face dorsale langue. (Absente = muqueuses bordantes).



Le Point de Non-Retour [Predicted - Diagnostic Critical] : Le franchissement de la membrane basale par des cellules définit le basculement vers la malignité (cancer).

Le Lexique Pathologique et la Frontière Oncologique

TUMEUR BÉNIGNE		TUMEUR MALIGNE	
Bien limitée		Mal limitée	
Encapsulée		Non encapsulée	
Semblable au tissu d'origine		Différenciation aberrante	
Régulières		Irrégulières/cancéreuses	
Lente			Rapide
Refoulement sans destruction			Envahissement
Pas de récurrence après exérèse			Récurrence possible
Pas de métastase			Métastase(s)

Tumeur : Tissu nouvellement formé, dysfonctionnement cellulaire, souvent sans inflammation.

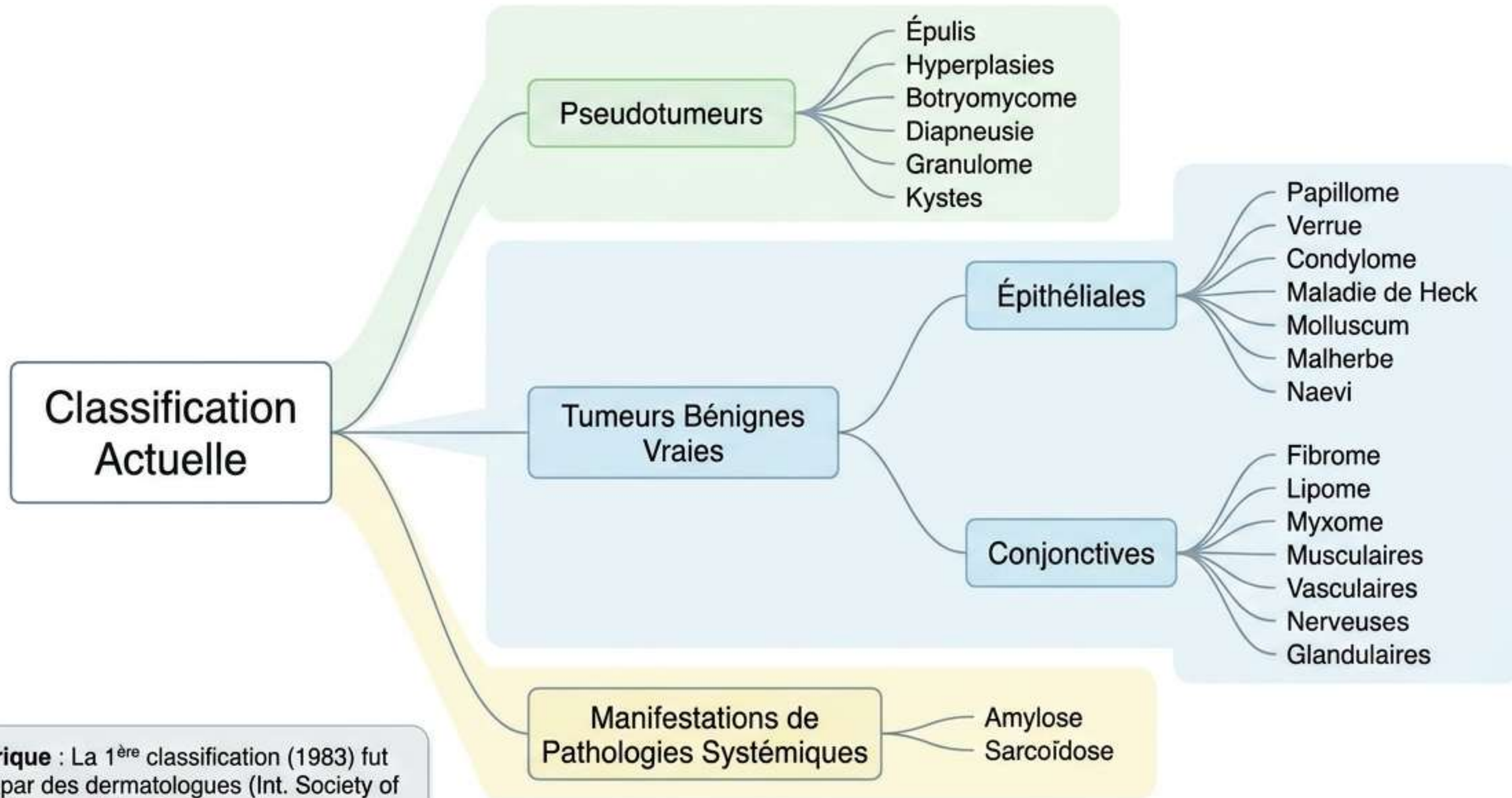
Pseudo-tumeur : Aspect tumoral mais dû à dystrophie, inflammation ou malformation. PAS néoplasique.

Hyperplasie [Predicted - Terminology trick] : Augmentation du volume par augmentation du NOMBRE de cellules.

Hypertrophie [Predicted - Terminology trick] : Augmentation du volume par augmentation du VOLUME (taille) des cellules.

Atrophie : Diminution épaisseur par baisse du nombre de couches.

La Taxonomie des Tumeurs Buccales



Historique : La 1^{ère} classification (1983) fut créée par des dermatologues (Int. Society of Tropical Dermatology), classant purement par tissu d'origine.

Pseudotumeurs Fréquentes : L'Épulis

Inflammatoire



Rouge sombre, ulcérée, saignante.

Fibreuse



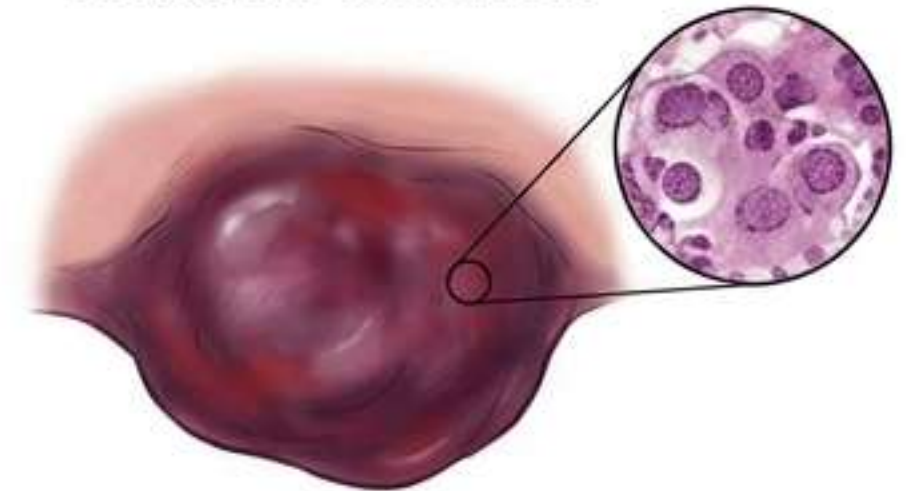
Ferme, même couleur que la gencive (origine: ligament parodontal).

Vasculaire / Granulome Pyogénique



Rouge vineux, désordonnée, saigne intensément.

Cellules Géantes



Rouge foncé/violacé, élastique.

ÉPULIS : Exclusivement sur la gencive (0,5 à 1,5cm)

Étiologies : Épine irritative, tartre, malpositions dentaires [Ref: Q18]. Facteur hormonal (grossesse) [Ref: Q18]. Diabète, crase sanguine.

Signe Clinique Majeur : NE s'accompagne JAMAIS d'adénopathies satellites [Ref: Q18]. Indolore, souvent ulcérée par mastication.

Autres formes : Congénitale (Neumaan), Gravidique (régresse après accouchement).

Pseudotumeurs Mécaniques : Prothèse et Succion

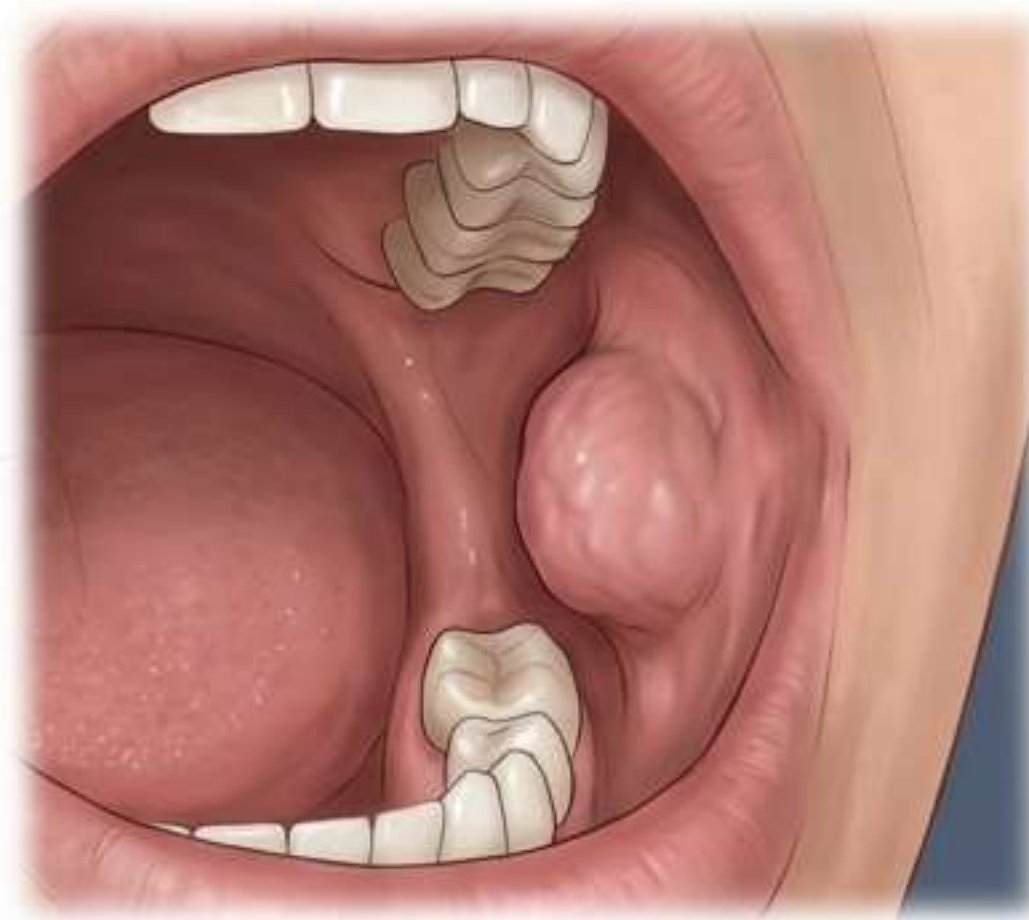
A. Hyperplasie Fibreuse Prothétique (Épulis Fissuratum / Feuillet de livre)



Double la crête alvéolaire dans le vestibule. Complication médiate d'une prothèse ancienne/instable [Ref: Q8, Q37].

1. DÉPOSE / Confiscation de la prothèse responsable [Ref: Q11, Q17]
2. Excision chirurgicale
3. Anapath obligatoire [Ref: Q17]
4. Nouvelle prothèse [Ref: Q37]

B. Diapneusie



Tic de succion/aspiration face à un espace édenté. Siège: Joue interne, lèvre, commissure [Ref: Q13, Q40]. Nodule sessile.

Hyperplasies latrogènes et Lésions Localisées

Hyperplasies Médicamenteuses (Envahissent couronnes)



Dihydan
Antiépileptique



Adalate
Nifédipine,
Anticalcique

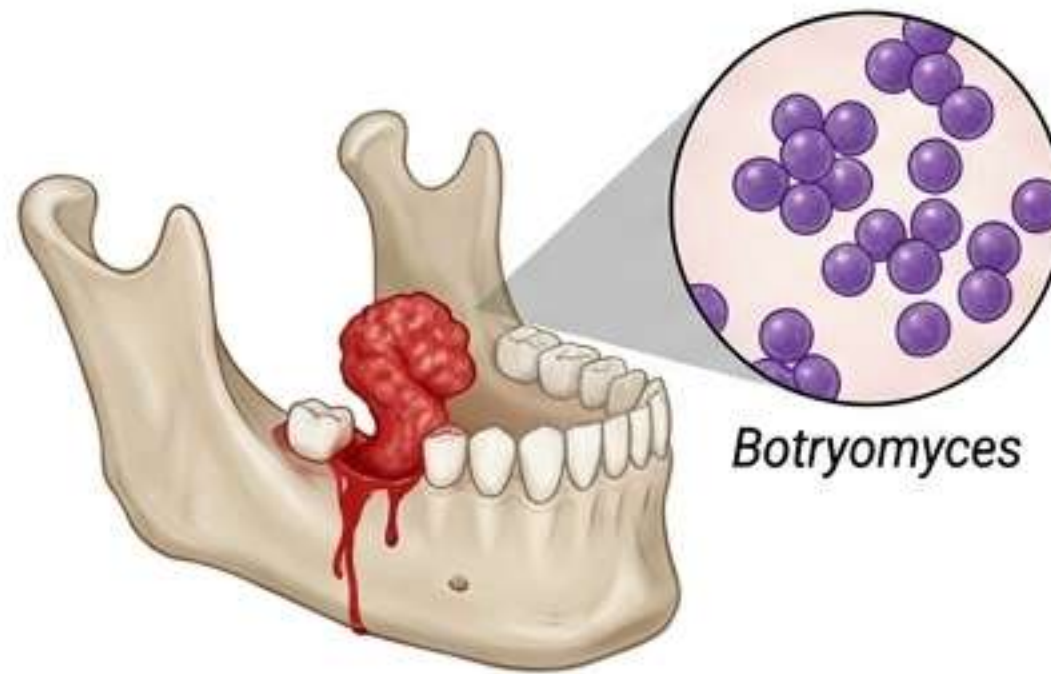


Ciclosporine A
Immunosuppresseur



- **Dihydan** (Antiépileptique, 30-60% cas) [Ref: Q14 2020].
- **Adalate/Nifédipine** (Anticalcique) [Ref: Q10].
- **Ciclosporine A** (Immunosuppresseur, 70% cas) [Ref: Q10].

Botryomycome



Botryomyces

Réponse inflammatoire exagérée
avec facteur microbien surajouté
(*Botryomyces*) [Ref: Q14 2019].
Rouge vif, friable.

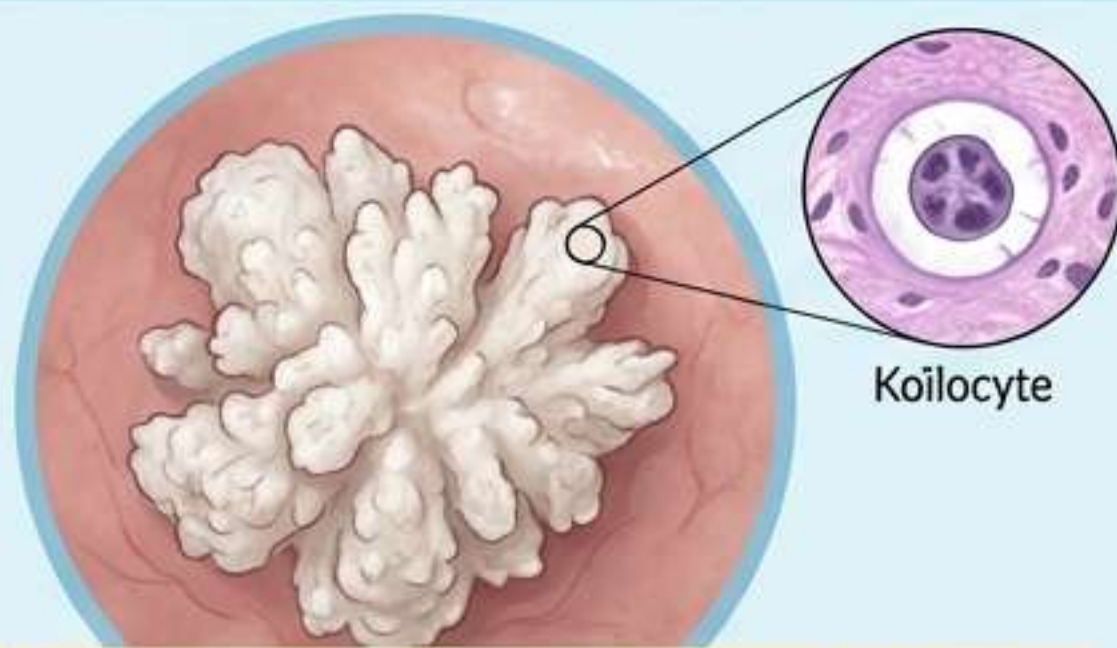
Kyste Papille Palatine



Reste du foramen incisif. Molle.
Aucune image radiologique.

Bonus Annale : Ouranite palatine : Lésion en calque due à la chaleur [Ref: Q17 2018].

Tumeurs Vraies Épithéliales : L'Empreinte Virale (HPV)



Papillome : Aspect en chou-fleur. Histologie: Koilocytes.
Ne régresse PAS spontanément. Confondu avec verrue [Ref: Q7].



Verrue : Mécanisme d'Auto-inoculation digitale
[Ref: Q7].



Condylome Acuminé : MST (HPV 6, 11). Incidence très
accrue chez patients VIH/SIDA [Ref: Q13].



Maladie de Heck : HPV 13 et 32. Régression
spontanée fréquente [Predicted - Detail].

ALERTE: Papillomatose Orale Floride : Lésion généralisée. Transformation maligne TRÈS FRÉQUENTE (biopsies multiples indispensables)

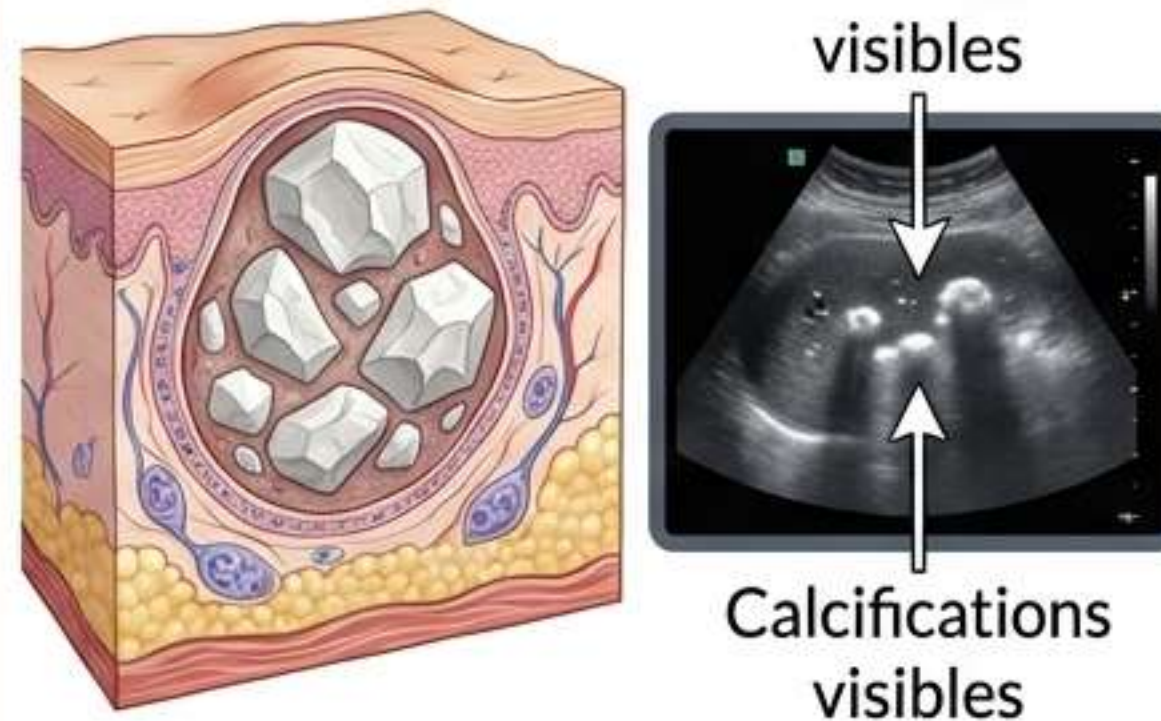
Tumeurs Vraies Épithéliales : Pox Virus, Annexes et Naevi

Molluscum Contagiosum



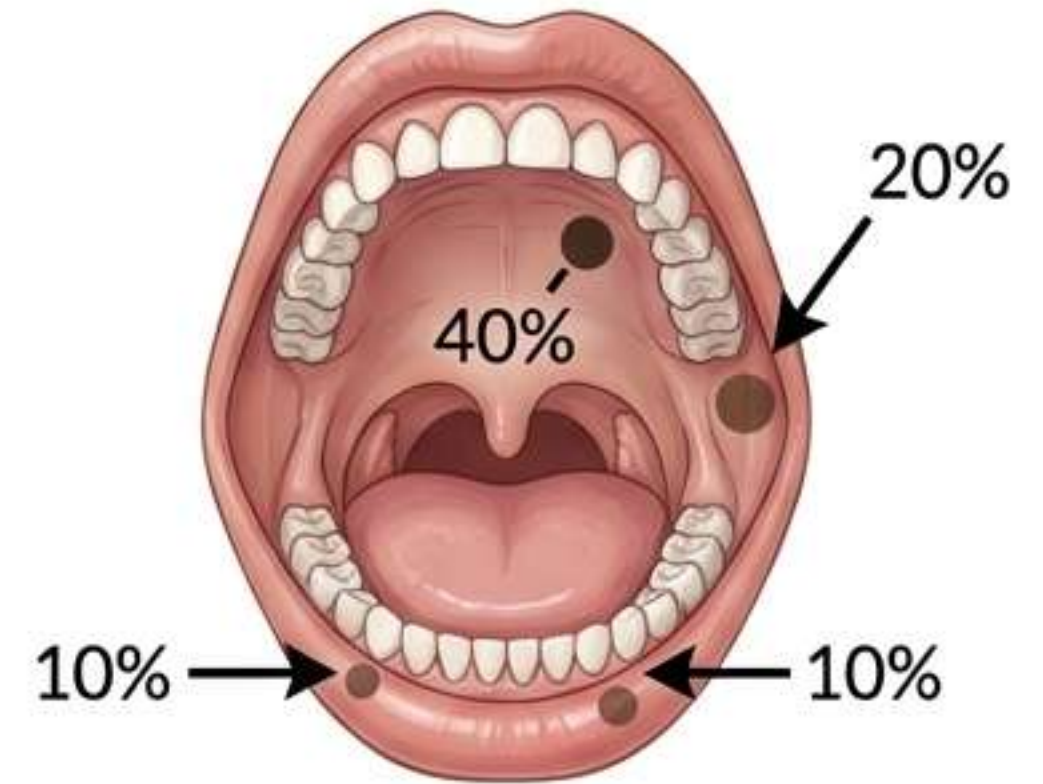
Molluscum (Pox Virus) : Signe pathognomonique = Dépression centrale contenant un bouchon de kératine (liquide crémeux) [Predicted - Clinical sign].

Épithélioma calcifié de Malherbe



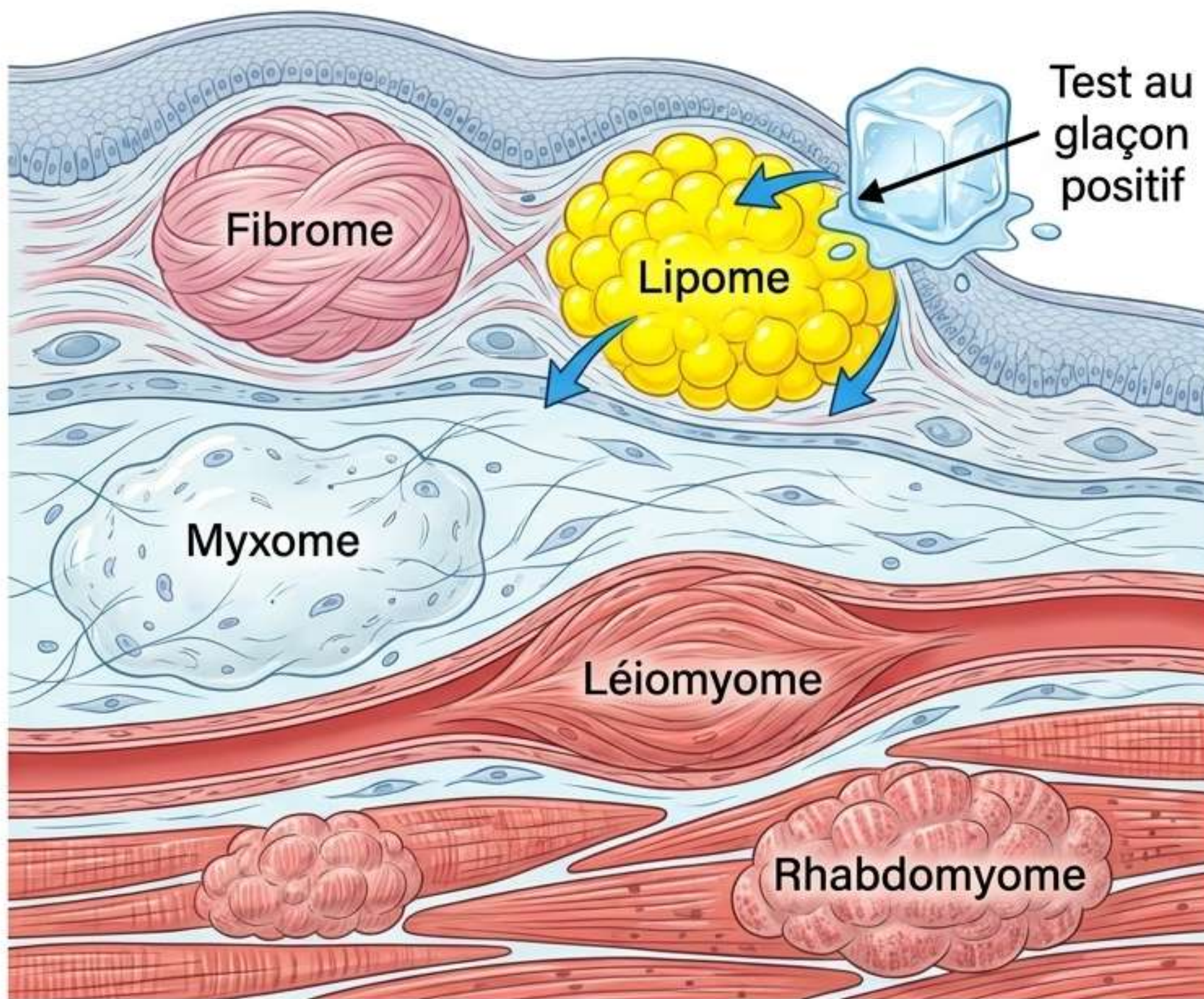
Dérive du follicule pileux.
Consistance pierreuse.
Histologie: Cellules matricielles + Cellules momifiées calcifiées.

Naevi (Anomalie des Mélanoblastes)



Découverte tardive (20-40 ans).
Abstention ou exérèse si zone d'irritation.

Tumeurs Conjonctives et Musculaires



Fibrome : Prolifération fibroblastes. Nodule ferme, lisse.

Lipome : Adipocytes. Couleur jaunâtre caractéristique. Se durcit et se rétracte au contact du froid (Test au glaçon) [Predicted - Clinic test].

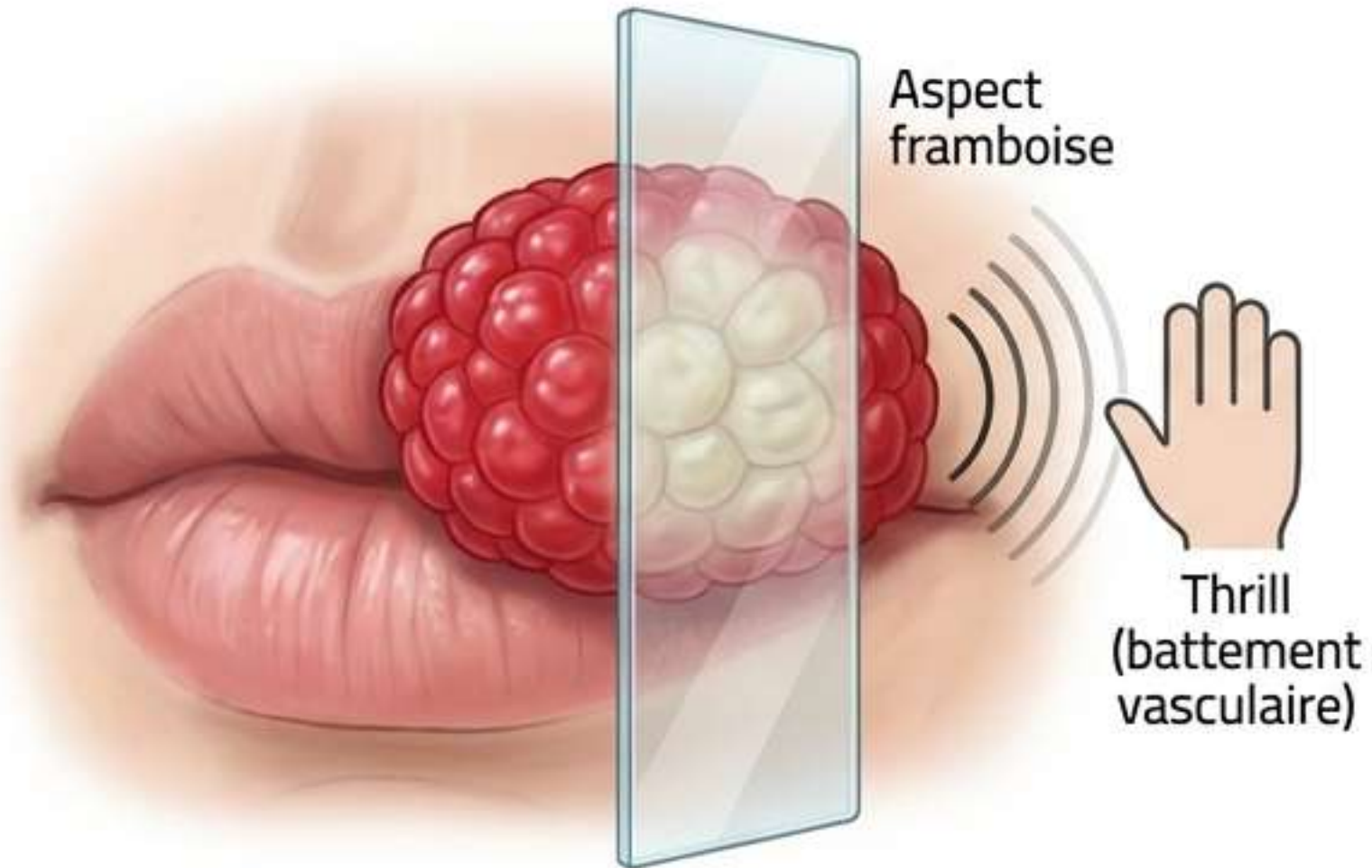
Myxome : Cellules mésenchymateuses indifférenciées, stroma myxoïde.

Léiomyome : Muscle LISSE (dérive des parois vasculaires ou papilles caliciformes).

Rhabdomyome : Muscle STRIÉ (langue). Peut s'associer à la maladie génétique : Sclérose Tubéreuse de Bourneville [Predicted - Systemic link].

Tumeurs Vasculaires : Danger Hémorragique

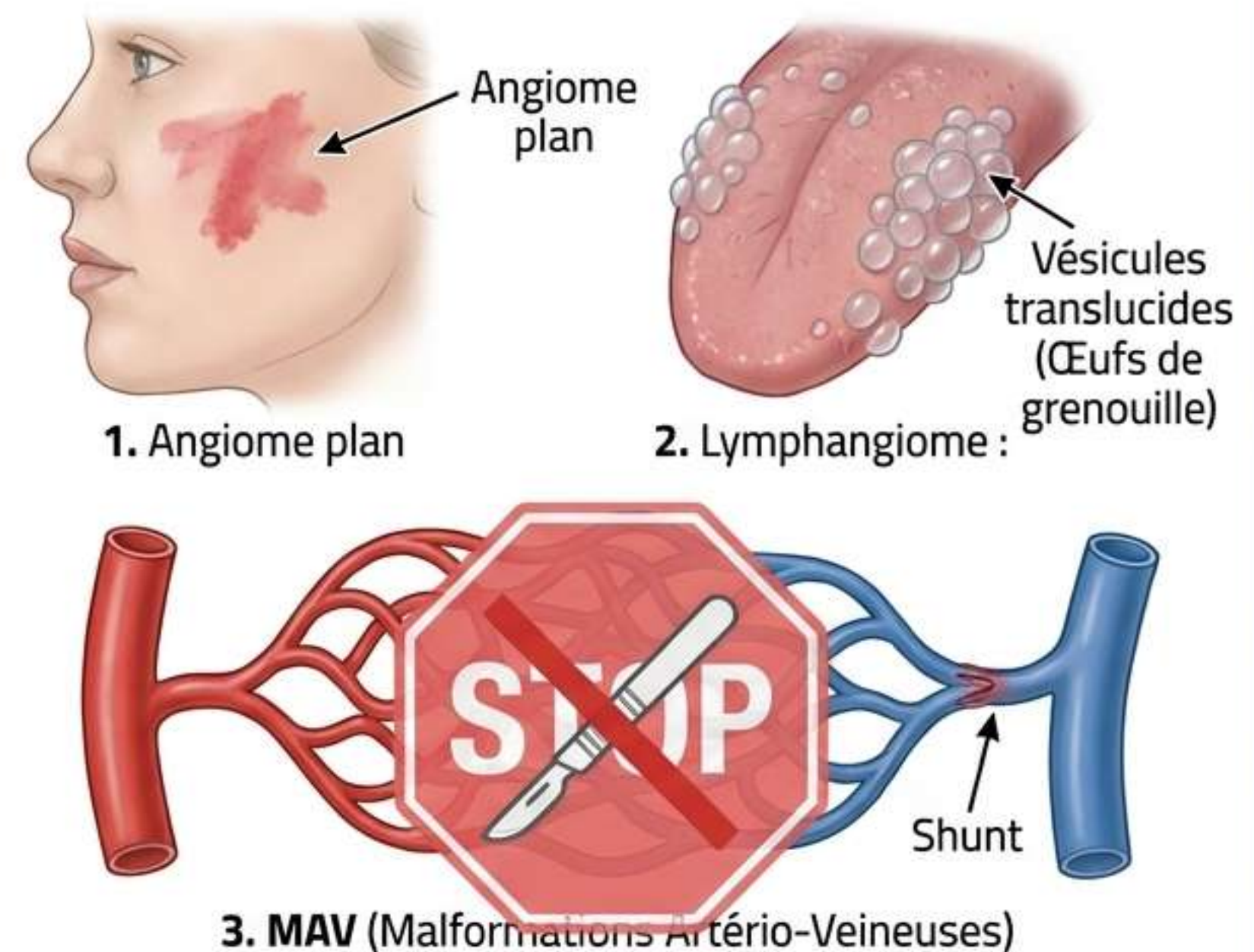
Les Hémangiomes (Prolifération endothéliale)



Signes pathognomoniques : Disparition de la couleur à la pression (Vitropression positive) et sensation de Thrill (battement vasculaire)
[Ref: Q14 2018]

Règle Chirurgicale Majeure : NE JAMAIS exciser d'emblée (risque hémorragique vital). Embolisation préopératoire obligatoire si chirurgie [Predicted - Surgical rule]

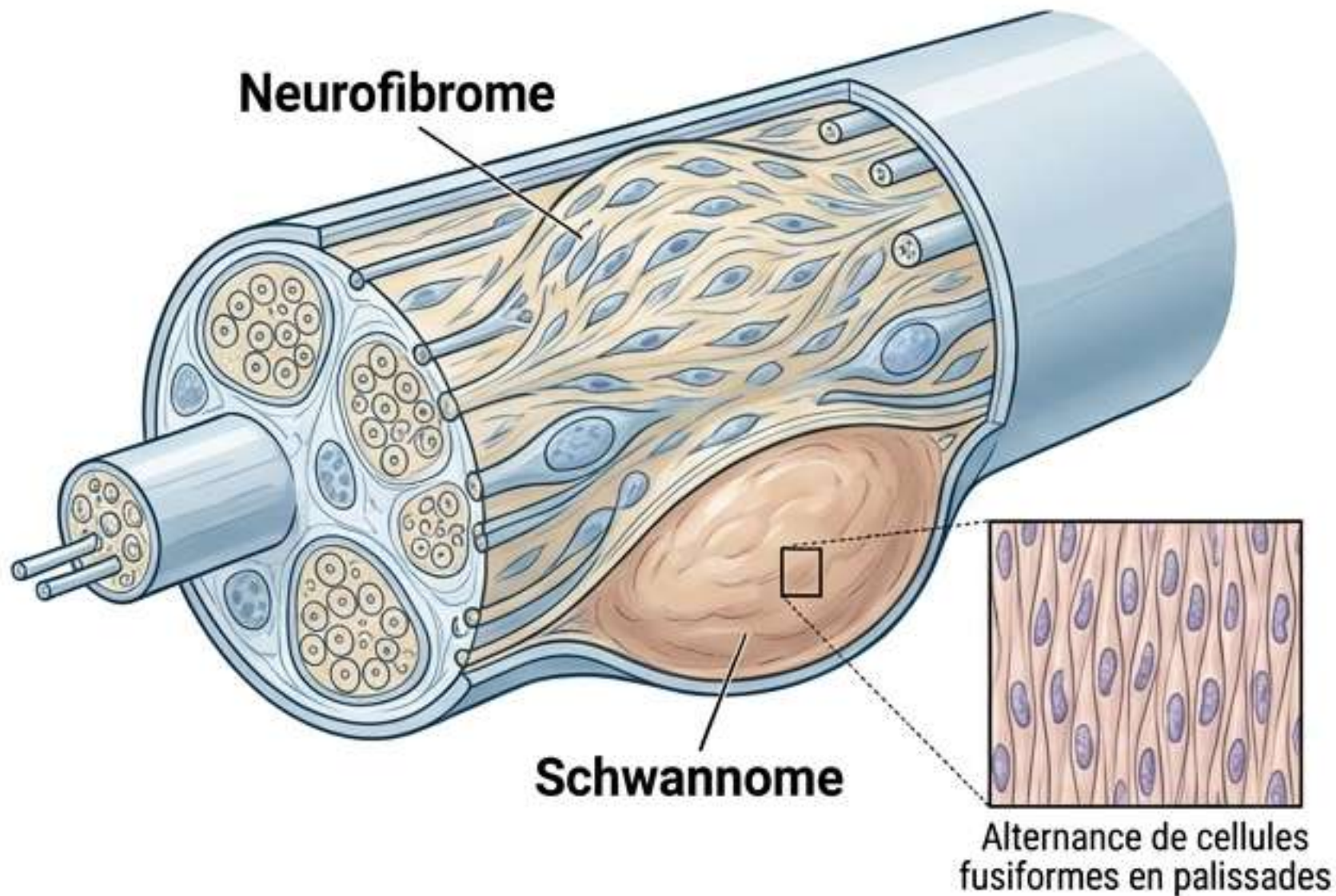
Malformations Vasculaires (Anomalies capillaires)



Incertitude évolutive et grand risque hémorragique chirurgical
[Ref: Q14 2018]

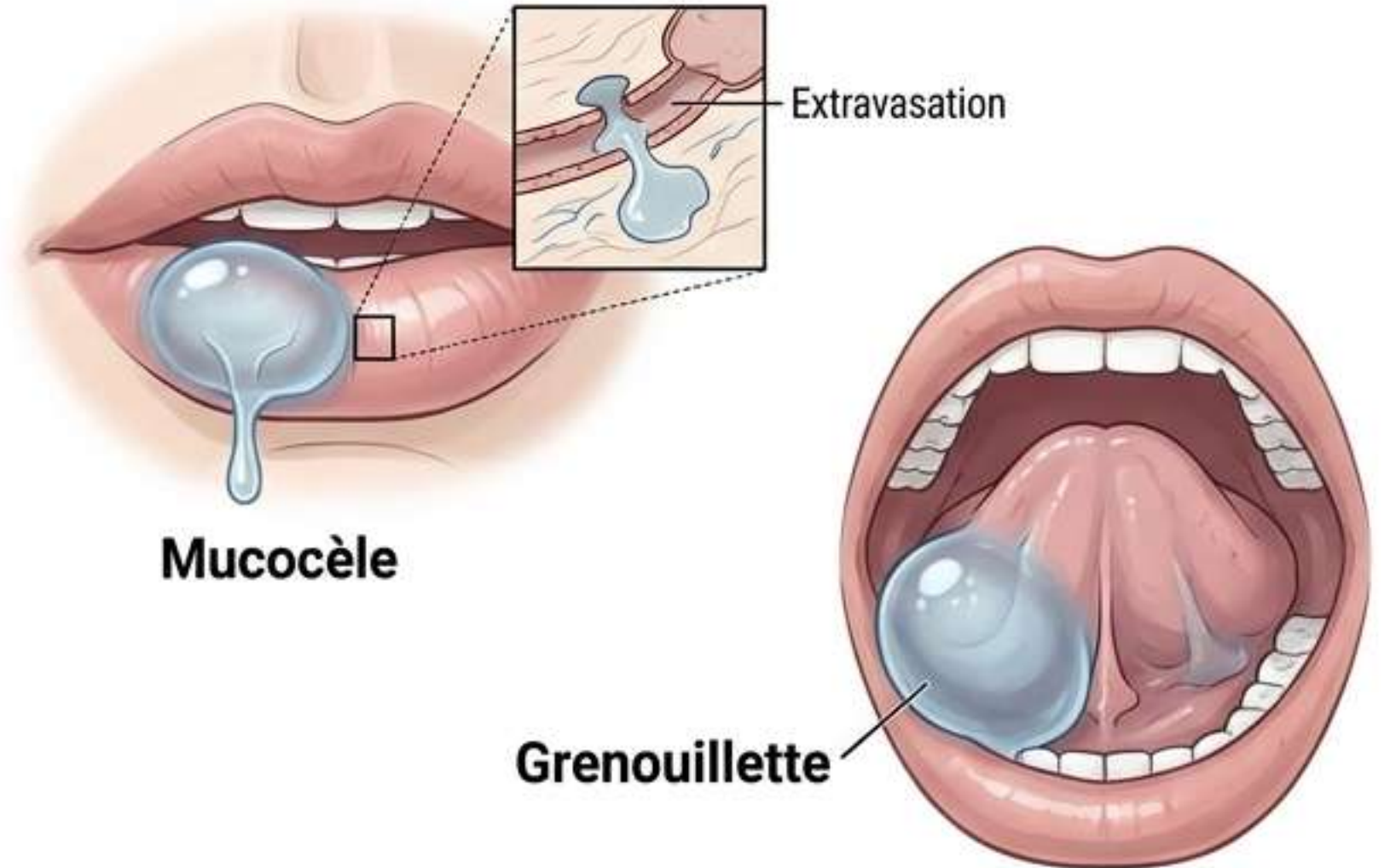
Tumeurs Nerveuses et Glandulaires

Tumeurs Nerveuses



- **Neurofibrome** : Dérive de l'endonèvre.
- [Peut s'inscrire dans le cadre de la Neurofibromatose de Recklinghausen (atteintes multiples) [Predicted - Systemic].]
- **Schwannome** : Dérive des cellules de Schwann. Histologie typique en palissades. Exérèse complète.

Tumeurs Glandulaires



- **Mucocèle (lèvre)** : Kyste mucoïde par extravasation (rupture, trauma) ou rétention.
- [Contenu salivaire : Liquide décrit cliniquement comme visqueux, tel du 'blanc d'œuf cru' [Predicted - Clinical Hint].]
- **Grenouillette (Ranula)** : Touche exclusivement le plancher buccal (Glande sublinguale). Aspect bleu translucide imitant un ventre de grenouille.

Pathologies Systémiques et Protocole Opératoire

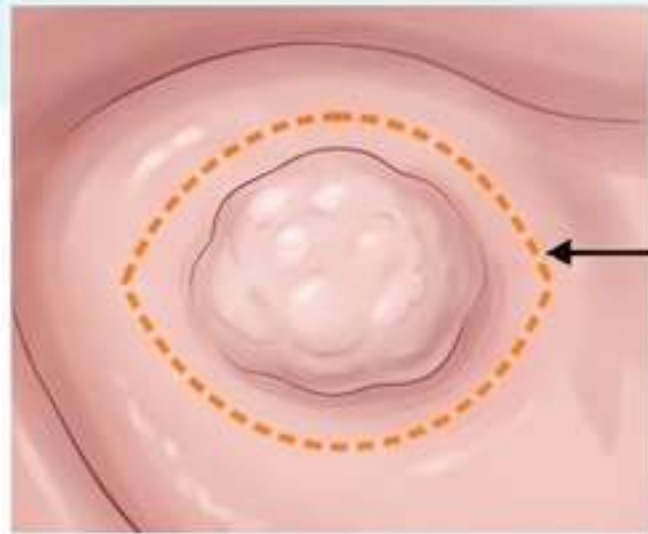


PAS DE NÉCROSE CASÉUSE

Les Formes Systémiques

Sarcoïdose (Maladie de Besnier-Boeck-Schaumann) : Manifestation orale par granulomes épithélioïdes, strictement SANS nécrose caséuse (contrairement à la tuberculose) [Predicted - Diff Dx].

Amylose: Macroglossie par dépôts protéiques.



Incision
elliptique
(en quartier
d'orange)



L'Approche Chirurgicale Universelle

Le traitement est Essentiellement CHIRURGICAL.
Dogme absolu : Toute pièce opératoire doit obligatoirement être soumise à une analyse Anatomo-pathologique [Ref: Q14 2017, Q17].

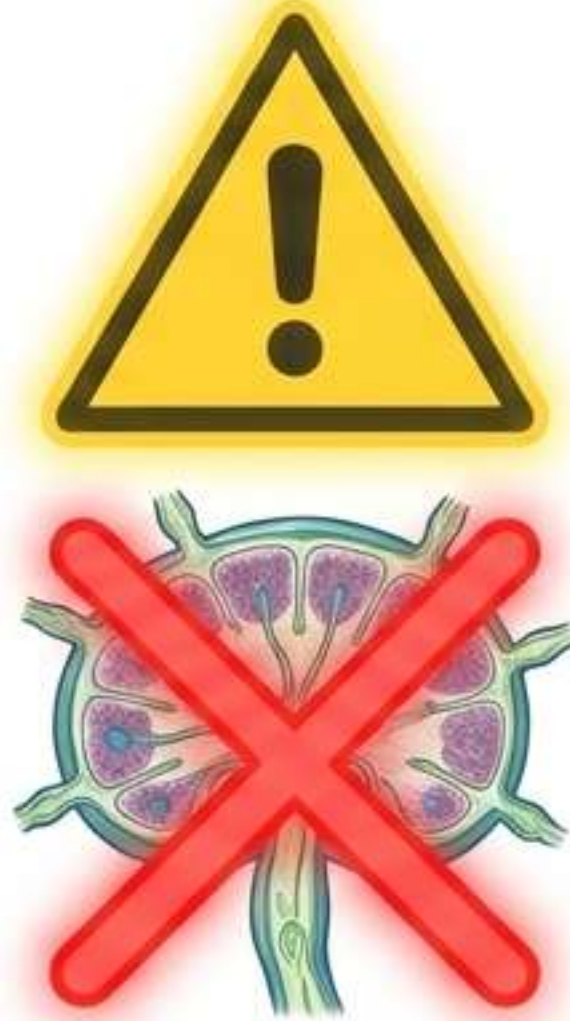
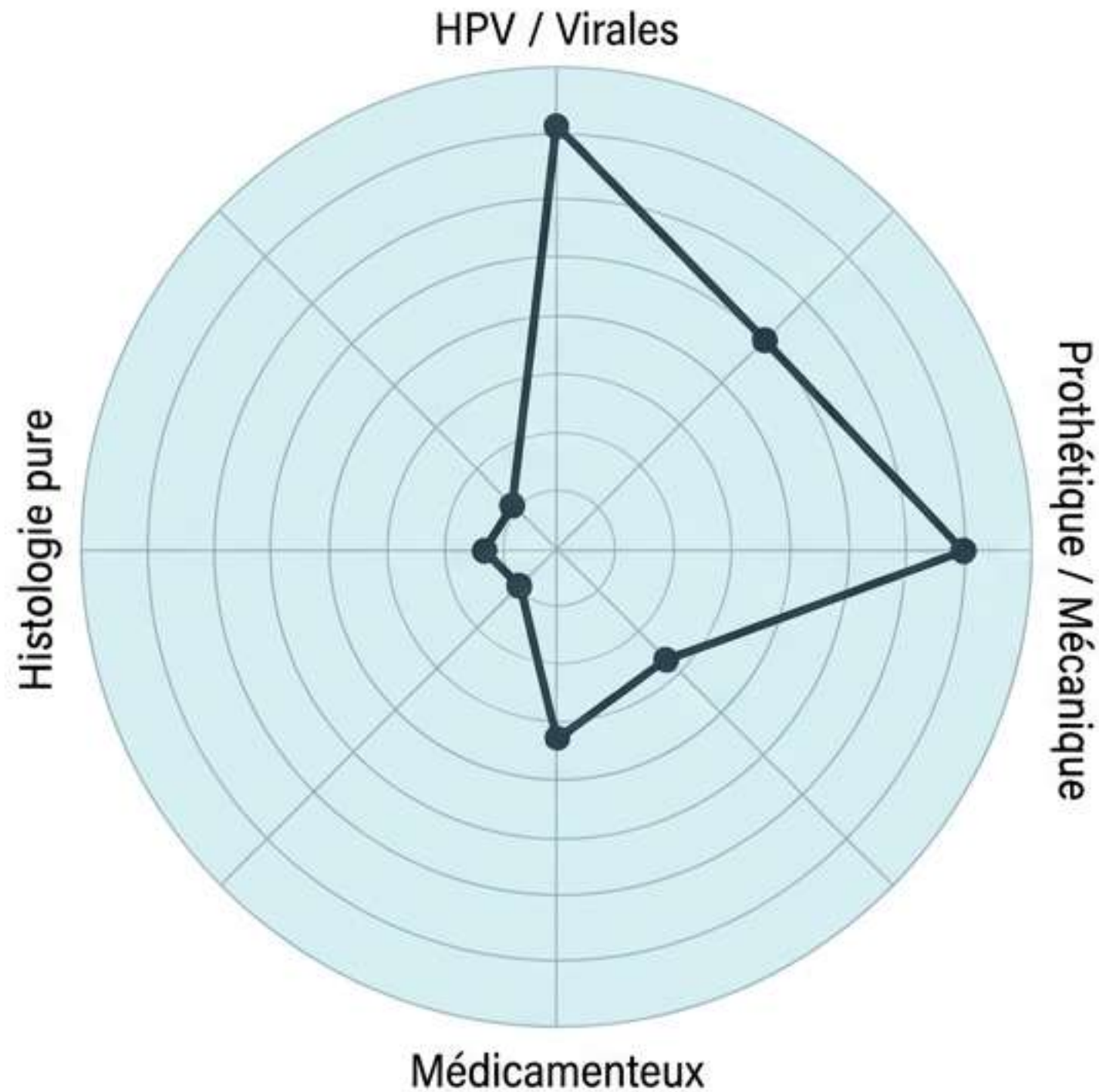


Mèches
iodoformées

Exception Chirurgicale - La Marsupialisation

Traitement de la Grenouillette : Marsupialisation (suture des bords + mèches iodoformées) pour préserver la glande sublinguale, évitant le sacrifice glandulaire total [Predicted - Surgery detail].

Exam Pattern Analysis (Stratégie d'Évaluation)



**Piège:
Adénopathie**

Récurrences Majeures (Haute Fréquence)

- **Hyperplasie Prothétique** : L'axe chronologique de traitement (Dépôt appareil PUIS chirurgie) est le grand classique.
- **Condylome vs Papillome** : Distinction entre lien MST/VIH vs Auto-inoculation.

Pièges Classiques Fréquents

- **Épulis** : IL N'Y A JAMAIS d'adénopathie satellite. (Testé massivement).
- **Diapneusie** : Le tic d'aspiration nécessite impérativement un espace édenté.

Entités Hors-Chapitre (Testées en Annale)

Kératokyste : Kyste odontogénique pouvant englober une dent incluse. Associé au syndrome de Gorlin-Goltz [Ref: Q15 2024].

Actinomycose : Tuméfaction mamelonnée avec fistules multiples (liquide séro-sanguinolent). Agent causal : Actinomyces bovis [Ref: Q3 2023].

Arbre Décisionnel et Cartographie Mentale Globale

